

INTERVIEW PRESENTATION

대표 프로젝트 성과와 DAI 플랫폼 구축 기여 방안

AI 헬스케어 플랫폼 팀장 지원

정치성 · 2026.09.16

사용자와 현장의 문제를 제품과 운영의 개선으로 연결해 온 경험

복잡한 요구를 서비스 정책과 업무 흐름으로 구체화하고, 팀의 실행으로 연결해 왔습니다.

경험 · 도메인	사용자가 완료할 일	현장의 처리 업무	무엇을 증명하나
굿리치 보험 · 인슈어테크	USER 보험분석을 위한 상담신청	OPS 상담 활용 정보의 품질 확인	전환
THK 장기요양 · 돌봄	USER 수급자 자격·구매 정보 조회	OPS 주문·직배송의 확인과 예외 처리	운영
더베스트페이 병원 원무	USER 예약·조회·수납	OPS EMR 연동과 기관별 요구 조율	연동
코나아이 지역화폐 · 결제	USER 지역화폐·카드 이용	OPS 3개 팀 요청의 우선순위·실행 관리	조직 실행

제품의 세부 내용을 이해하면서, 여러 조직의 실행을 함께 챙길 수 있습니다.

사용자가 무엇을 완료해야 하는지와, 운영자가 어떻게 처리해야 하는지를 함께 설계해 왔습니다.

보험분석 상담신청 페이지 전환율 20% 개선

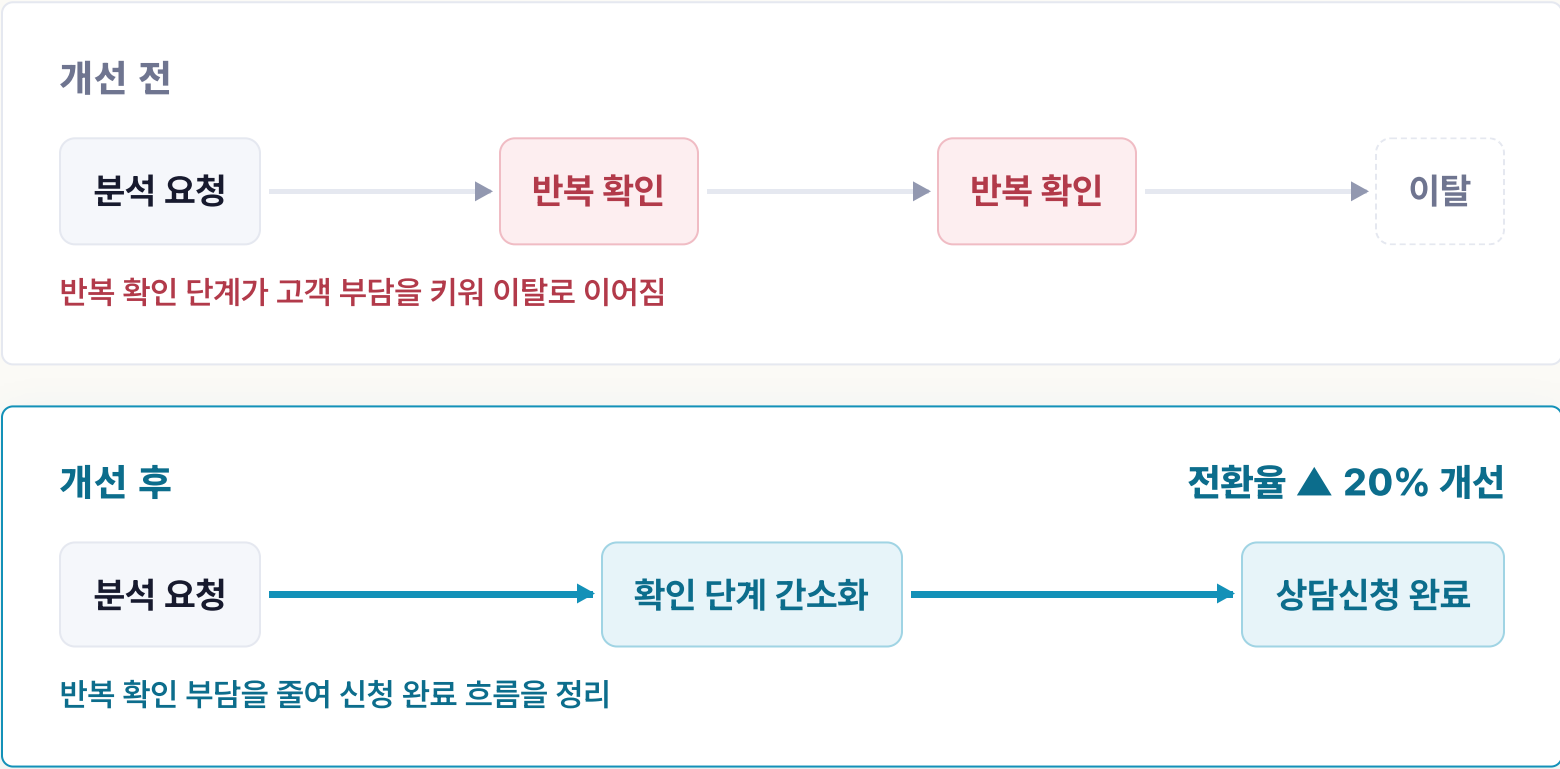
— 페이지 수정 전 대비, 해당 페이지의 상담신청 전환율

20% 개선

보험분석 상담신청 페이지의 상담신청 전환율,
수정 전 대비 개선

문제	상담신청 과정의 반복 확인 단계가 고객 부담·이탈 요인
실행	반복 부담을 확인하고, 확인 단계와 신청 흐름을 개선
결과	수정 반영 후 전환율 기존 대비 20% 개선
함께 확인	설계사 클레임 비율 점검 — 상담 활용 정보 품질

신청 과정 개념도 · 실제 화면 아님



직배송 확인 업무를 시스템으로 구조화

— 일일 처리업무 약 6시간 → 약 2시간 · 고물량 제조사 적용 구간 기준

개선 전	재고 미보유 주문의 수기 확인 ·제조사 개별 연락, 진행·예외 확인에 업무 집중
본인 변경	주문 상태·처리 흐름 을 정리하고, 담당 업무·예외 처리를 관리자 시스템에 반영
적용	제조사별 운영 여건에 맞춰 적용

약 30%

보조 근거 · 수급자 조회·관리 기능 이용률
수급자 자격·급여 기준·구매 정보 조회·관리 기능을 함께
고도화

일일 처리업무 시간 비교 · 고물량 제조사 적용 구간 기준



EMR API와 환자 이용 흐름을 연결한 원무 서비스 기획



1

원무 모바일 서비스
환자 이용 흐름 · 운영 확인 · 예외 처리 고려

▲ 기존 API 연동 (수행)

2

기존 EMR API
업체가 제공하는 데이터·기능 범위

▲ 원무 절차 기반 기능 검토·조율 (수행)

3

병원 원무 절차
병원·EMR사·개발조직 요구사항 조율

제안 · 검토 (수행 아님)

반복 기능의 공통화

병원 공통 통합 플랫폼 방향

완성한 성과가 아니라, 검토·제안 단계

수행 경험 — 기존 API 기반 기획·조율 제안 · 검토 — 공통화·통합 방향	병원별 차이 기관마다 요구사항이 다름	EMR 업체별 차이 제공 데이터·기능이 상이	추가 개발·협의 협의·비용이 별도로 필요
---	---	---	---

여러 사업의 요청을 우선순위와 팀별 책임으로 정리

본인 · 팀장
3개 팀 운영

코나카드	직접 겸직
지역화폐	팀장 중심 운영
모빌리티	팀장 중심 운영

우선순위 판단 기준

- 외부와 합의한 일정·약속
- 법률·운영 위험
- 여러 요청을 함께 해결할 공통 과제

실행 관리

- 업무 배분과 백로그 정리
- PRD 목적·KPI ↔ 상세기획 연결 확인
- Figma 기반 산출물 공유·협업

DAI 적용 어려운 요구가 생기면 범위·일정·내부 인력·외부 협업의 선택안을 비교하고, 경영진 판단이 필요한 사안에는 추천안을 제시하겠습니다.

AI로 요구사항을 구체화하고, 적용 효과와 운영 품질을 함께 검토

지금까지 · 수행 경험

AI로 앞단을 구체화

- PRD · 기능정의 · 프로토타입 제작
- 테스트 데이터를 연결한 작동 프로토타입
- 사내 운영 업무의 도구화 · 자동화

DAI · 서비스 적용 기준

정식 적용은 이렇게 판단

- 어떤 사용자·운영 문제를 개선하는가
- 결과의 오류·누락을 어떻게 확인하는가
- 어떤 상황에서 사람이 검토하는가
- 데이터·연동·보안·운영 비용을 감당할 수 있는가

적용 예시

정보 요약 기능이라면 — 처리시간과 중요 정보 누락 여부를 함께 평가

향후 접근법입니다. 실제 의료 AI 프로젝트 성과가 아닙니다. 임상·규제 판단은 관련 전문가와 협업합니다.

사업 목표와 실행 조건에 따라 검증하고 확장

1 사업 · 현장 이해 ? 실제 사용자·도입 결정자·비용 주체와 기존 데이터·계약 조건은? 판단 결과 해결할 문제와 기대 성과 합의	2 우선 과제 선정 ? 고객 영향·사업 효과와 데이터·개발·운영 가능성은? 판단 결과 우선순위와 개발 범위 제안	3 불확실성 검증 ? 수요·연동·AI 품질·운영 중 핵심 불확실성은 무엇인가? 판단 결과 진행 · 범위 수정 · 보류 판단	4 구축 · 개선 · 확장 ? 실제 이용·운영 결과와 공통 활용 가능한 기준은? 판단 결과 보완 · 확대 여부 결정
--	---	---	---

← 검증 결과에 따라 앞 단계로 되돌아갈 수 있고, 이미 검증된 부분은 이어받습니다

경영진에게는 **선택의 근거와 추천안**을, 실행 조직에는 **명확한 범위와 판단 기준**을 제시하겠습니다.

먼저 증명할 두 가지 실행 가설

공개된 그룹 자산과 제 경험에서 좁힌 **가설**입니다. 확정 계획이 아니라, 입사 후 함께 검증할 출발점으로 제안합니다.

가설 A · 환자 경험 연결 흩어진 모니터링·관리 접점을 하나의 환자 흐름으로 잇는다	
가설	측정·관리 데이터가 한 흐름으로 이어지면 측정 지속·다음 행동 연결이 좋아진다
근거	그룹은 모니터링·관리 접점(하이카디·케어센스케어 등)을 이미 확보 — ‘잇는 경험’ 은 아직 빈자리
검증	소수 사용자 대상 얇은 연결 슬라이스 프로토타입으로 실사용·이탈 관측
성공·중단	실사용(채택) + 안전 인시던트 0 + 동의·규제 확인 통과 → 확장 / 미달 → 축소·보류

가설 B · 접근성 (원무 경험 이식) 예약~동의~결과 확인의 마찰을 줄여 등록·재사용을 높인다	
가설	등록·동의·조회의 마찰을 줄이면 디지털 헬스 접점의 등록·재사용률이 오른다
근거	EMR 연동 원무를 서비스화한 제 경험 이 그대로 붙는 지점
검증	한 개 접점에서 등록·동의·조회 플로우 개선안 을 실증
성공·중단	등록 완료율·재사용 관측 → 공통화 가치가 확인되면 확대

가설은 **입사 후 초기 진단**으로 갱신됩니다. 데이터 활용은 **환자 동의·규제 범위 확인이 전제**이며, 임상·규제 판단은 전문가와 함께합니다. 제품·조직·데이터 통합은 내부 상황을 파악한 뒤 확정하겠습니다.

CLOSING

DAI의 사업 과제를 제품과 운영으로 구체화하겠습니다

01 · 전환

사용자 행동과 사업 전환을
함께 본 경험

02 · 연동

현장 업무와 외부 시스템을
연결한 경험

03 · 실행

우선순위를 정하고
여러 팀의 실행을 이끈 경험

필요한 전문성과 협업하며, 판단의 근거와 실행 결과를 끝까지 설명하는 팀장이 되겠습니다.